جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هناء عبد الرحمن عبد المقصود يونس
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه اول **العنوان :** شبرا الخيمه اول
رقم البطاقة : 26102080104087 **رقم التليفون :** 01101715203 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 08-02-1961 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة الاجابات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هناء عبد الرحمن عبد المقصود يونس
National ID: 26102080104087

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ ومساعة الدخول : ---:-- yyyy-mm-dd	تاريخ ومساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٠١١٠١٧١٥٤٠٢



tient Name	:الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
atient No.	:26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	:2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	:Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed yous

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALN biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 13x8.5x4 cm , covering skin ellipse measured 13 x 4 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3 x2.5x2 cm .
- Distance from margins: 1 cm away from Superficial margin .
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm enclosing 12ALNs up to 1.5x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: present
- Lymph node involvement: Positive SLNs (3/12)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & left SLN biopsy:
Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS
- Positive LNs (3/12)
- Free margins
- Stage : pT2 , pN1

Dr. Rana Fathy Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Name: هناء عبد الرحمن عبد المقصود	
MR. : 5708	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient underwent an upfront left thoracic central quadrantectomy and axillary lymph node dissection in June 2025, with pathology revealing a T2 N3/10 disease. In August 2025, the multidisciplinary team recommended adjuvant chemotherapy with Endoxan and a planned 7-year course of aromatase inhibitor therapy. The patient was noted to be symptom-free at the 10 October 2025 follow-up.

In June 2026, the attending physician prescribed arimidex with supportive care for a duration of three months, with the next clinic visit scheduled for 5 September 2026.

On 7 September 2026, the physician documented that the patient was free of symptoms and continued adjuvant arimidex therapy for an additional three months. The current status is that the patient is receiving adjuvant arimidex for a total of 3 months.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13000891
Patient No.	: 26102080104067	Request Date	: 06/06/2023
Path No.	: SR-687/23	Verification Date	: 18/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: برام دار السلام - ثقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed you

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion
Nature of specimen:
Slide revision
Gross examination
4 slides +1 block (c-B1259)
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma .
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
* DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
*Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
* IPT :
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 5/8)
Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells
-Cytology slides :
Cellular smears showing groups and clusters of atypical ductal cells with increased nuclear cytoplasmic ratio with inflammatoy background.

Diagnosis:
Left breast lesion, slide revision of tru cut and cytology slides:
Invasive duct carcinoma, Grade II .
ER : Positive (8/8)

Verified by :
dr.esraa magdy

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: ام دار السلام - نقدة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed yo

Pathology Report

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Pathology Report
[DOCTYPE PATHOLOGY_REPORT]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



وزارة الصحة والسكان
المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى رام دار السلام
قسم الأشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 25/10/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

- **Breast density:** Predominant fatty tissue ... ***Matching ACR A.***
- **Focal asymmetry is seen in the left lower outer quadrant with few lesions of fat density with dystrophic calcifications within ,**
- **No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the both breasts.**
- Normal skin and nipple in the right breast.

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture.
- **Clear left operative bed, with few cystic lesions are seen close to 5-6 o'clock position ,the largest measures (9 x 7 mm).**
- **No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.**
- **No detected significant axillary lymph nodes.**

CONCLUSION:

- ***Post conservative surgery changes of the left breast with traumatic fat necrosis (BIRADS 2 Category).***
- ***Normal study of the right breast (BIRADS 1 Category).***

MUCH OBLIGED

DR.MONA ZAKY, MD.

prof-Breast imaging-Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

25/10/2025 11:21 AM

1- Patient ID:
2- Name :
3- Medical number: 03145671
Female
Sex
2-ID number: 3610208010[illegible]
Patient age : 63 Y

Family history
marital status
Co morbidity
Nil
Priors
NIS Score
Menopausal status
BMI
Reason of HRT
Date of HRT

Breast Imaging :

Clinical data

Mets Workup :
none

BX:	ER:	PR:	Her 2 neu :	SISH :	KI67 :
IDC	8/8	6/8			

T	N	M
2	2	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY
PATHOLOGY REPORT REQUESTE DATE 25/7/2023 [illegible] OF FRONT LT BESSEL
FREE RESECTION MRGINS ,,AXLND
LN 5/12

ADJUVANT PLAN

4 cycles DC(taxotere anthaxan),, PORT,, ADJUVANT AI for 5-7 years,, baseline DEXA scan

MEDICAL ONCOLOGY	Sh.K Rao	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALN biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 13x8.5x4 cm , covering skin ellipse measured 13 x 4 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3 x2.5x2 cm .
- Distance from margins: 1 cm away from Superficial margin ,
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm enclosing 12ALNs up to 1.5x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: present
- Lymph node involvement: Positive SLNs (3/12)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & left SLN biopsy:
Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS
- Positive LNs (3/12)
- Free margins
- Stage : pT2 , pN1

Dr. Rana Fathy Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

عمارة رقم (4) - الدور الأول - شارع رقم (207) - الزمالك الغربي - بجوار الكنيسة - القاهرة - مصر
Annex No. (4) - First Floor-Building No. 207- Nile Corniche - Mits El Qadeem- Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13000891
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 06/06/2023
Path No.	: SR-687/23	Verification Date	: 18/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion
Nature of specimen:
Slide revision
Gross examination
4 slides +1 block (c-B1259)
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:
* Histological type: Invasive duct carcincma .
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
* DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
*Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
* IPT :
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 6/8)
Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells
-Cytology slides :
Cellular smears showing groups and clusters of atypical ductal cells with increased nuclear cytoplasmic ratio with inflammatoy background.

Diagnosis:
Left breast lesion, slide revision of tru cut and cytology slides:
Invasive duct carcinoma, Grade II .
ER : Positive (8/8)

Verified by :
dr.esraa magdy

مقطعي

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 2023/2051	38700 DLP: 677.1 (mGy.cm)

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

***** Newly discovered left breast mass:***

Findings:

- The left breast shows ill-defined speculating mass noted in the UOQ measuring about 48 x 39 mm. Clear both lung fields
- Other than thick atelectatic bands noted in the lingular and middle lobes, no sizable pulmonary nodule, masses or cavitations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***No CT evidence of pneumonia***

DR. MOHAMMED MAHJOUB

Dr. Amr Farouk, M.D.

Research Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج البحثي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex:
2-ID number: 26102080104067

3- Medical number: 83145471
Female
Old Hos : 2021/2023
Patient Age : 62 Y

Family history	-VE	Phone	01120934150	BMI	30	REASON OF MDT	
marital status		NRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup : FREE

BX: IDC GII 6/23 SLIDE REVISON	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 :

T	N	M
CT2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

for LT central quadrentectomy and alnd

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ لؤي القاسم د/ آلاء جبل	RADIOLOGY	
SURGERY	د/ محمود طه	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex: Female
3- Medical number: 03145071
Old Med : 12651/2022
2-ID number: 26102080104087
Patient Age : 63 Y

Family history	-VE	Phone	01120834211	BMI	38	REASON OF MDT	POST [illegible]
marital status		BRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	2023-08-29
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :			Mets Workup : FREE		
BX: IDC	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 : 15

T	N	M
2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY
PATHOLOGY REPORT REQUESTE DATE 25/7/2023--- UP FRONT LT BCS&SLNB
FREE RESECTION MRGINS ,,AXLND
LN 3/12

MDT OUTCOME & PLAN

4 cycles DC(taxotere endoxan),, PORT,, ADJUVANT AI for 5-7 years,, baseline DEXA scan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ [illegible]	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Paychiatric		Nutrition	

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALN biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 13x8.5x4 cm , covering skin ellipse measured 13 x 4 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3 x2.5x2 cm .
- Distance from margins: 1 cm away from Superficial margin ,
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm enclosing 12ALNs up to 1.5x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: present
- Lymph node involvement: Positive SLNs (3/12)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & left SLN biopsy:
Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS
- Positive LNs (3/12)
- Free margins
- Stage : pT2 , pN1

Dr. Rana Fathy Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Room No. (4) - First Floor-Building No. 9871- 90th Corniche - Nile El Qadema- Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :
Dr.Heba Hasan

عمارة رقم (9) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - الشارع الأول - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 287- 26th Corniche - Misr El Qadeem - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 03/08/2024
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size , smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: Average size , displaying homogenous echopattern.

Right Kidney: -

- Is of normal size measures 9.9x3.8 cm showing increased echogenicity and loss of differentiation between cortex and medulla ,cortical thickness varies from 3mm opposite upper lobe and 12mm opposite lower lobe , no stone or backpressure changes , few small simple cysts.

Left Kidney: -

- Is of normal size measures 10x5 cm , altered echogenicity , no stone or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: -: average sized uterus. With calcified uterine fibroid at anterior wall

- No ascites or abnormal fluid collection.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

Opinion:

- Right renal old pyelonephritic changes as described
- Left kidney showing mild increased echogenicity for lab correlation.
- Few small simple cysts.

Best Regards,

Dr. Shahd M. Fouad, MSc, FRCR.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13000891
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 06/06/2023
Path No.	: SR-687/23	Verification Date	: 18/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion
Nature of specimen:
Slide revision
Gross examination
l slides +1 block (c-B1259)
ections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, R,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

icroscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma .
rade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
CIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
gioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
T :
Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 6/8)
2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
: 15 % nuclear reaction in tumor cells
logy slides :
lar smears showing groups and clusters of atypical ductal cells with increased nuclear lasmic ratio with inflammatoy background.

osis:
ast lesion, slide revision of tru cut and cytology slides:
duct carcinoma, Grade II .
ve (8/8)

erified by :
sraa magdy

Patient Name	الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	13000891
Patient No.	26102080104087	Request Date	06/06/2023
Path No.	SR-687/23	Verification Date	18/06/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	62 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

PR : Positive (6/8)
HER2: Negative (score0)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Israa Elgendy
Dr.Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Building No. 80 - Cairo - Egypt - 1987 - Nile Corniche - Nasr El Qobbah - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 62 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 38700/2051/2023

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- *. The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

Average size for, homogenous.

- **Kidneys: -**
- *Both are average in size, shape*
- *The right kidney shows increase echogenicity, upper zone cyst 17mm*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

***Para-aortic and pancreatic area**: show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

***Uterus and adenexeal** ; no abnormalities could be detected*

Opinion:

Right echogenic kidney with simple cyst for laboratory correlation

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 2:16 2023/06/05

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
قسم الايكو

Echo report

MR:

Name:

Date: 2023

EF	60	55-75%	PWT	1,1	
LVEDD	4,55	3.5-5.8cm	AO.R	2,27	2-3.7cm
LVESD	2,95	2-4cm	LA	3,21	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT		0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Concentric LVH

LV wall thickness normal

LV diastolic function DD G1

SWMA No RWMA.

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve mild MR

Aortic valve Sclerotic & mild AR

Tricuspid valve normal

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion No masses, no effusion

D/ Msc cardiology

MRS HANAA ABD EL RAHMAN
Date : 27/ 5 / 2023

Dear Colleague Prof.Dr. BAHAA EL WAKEEL

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY :

- The left breast show an irregular Partially ill defined dense mass in the retroareolar area
- No micro nor microcalcification seen
- No pathological lymph nodes seen

By complementary U/S

- The left breast show an irregular solid mass measuring 40 x 26 mm in the periareolar area at 7 o'clock with picture of malignant breast mass BIRAD V
- Normal size, shape, skin, subcutaneous tissue, nipples and areola
- No pathological lymph node seen , but multiple reactionary lymph nodes

OPINION :

Picture of left side breast malignant mass

MUCH OBLIGED, YOURS
DR.EID RAMADAN

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 2023/2051	38700 DLP: 677.1 (mGy.cm)

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

***** Newly discovered left breast mass:***

Findings:

- The left breast shows ill-defined speculating mass noted in the UOQ measuring about 48 x 39 mm. Clear both lung fields
- Other than thick atelectatic bands noted in the lingular and middle lobes, no sizable pulmonary nodule, masses or cavitations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***No CT evidence of pneumonia***

DR. MOHAMMED MAHJOUB

Dr. Amr Farouk, M.D.

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 25/10/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

- **Breast density:** Predominant fatty tissue ... ***Matching ACR A.***
- **Focal asymmetry is seen in the left lower outer quadrant with few lesions of fat density with dystrophic calcifications within .**
- **No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the both breasts.**
- Normal skin and nipple in the right **breast.**

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture.
- **Clear left operative bed, with few cystic lesions are seen close to 5-6 o'clock position ,the largest measures (9 x 7 mm).**
- **No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.**
- **No detected significant axillary lymph nodes.**

CONCLUSION:

- ***Post conservative surgery changes of the left breast with traumatic fat necrosis (BIRADS 2 Category).***
- ***Normal study of the right breast (BIRADS 1 Category).***

MUCH OBLIGED

DR.MONA ZAKY, MD.

prof-Breast imaging-Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

25/10/2025 11:21 AM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Anes workup	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ..... رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
4/5/21		Post Chemo SC extravasation burn Plean for 1- Mebo Cre 2- Augmentin 1g tab 3- Declofen tab 75	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ...

رقم الملف: ...

W 96
L 1675
BSA 1.9

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		female pt. 62 y pt. for adjuvent eth taxotere / endoxan x 4 cycles Labs adapted exp 8 Creat 1.7 taxotere 75 mg/m² 140mg Endoxan 600mg/m² 1140 C1	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Page 1 of 1

Research Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج البحثي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex:
2-ID number: 26102080104067

3- Medical number: 83145471
Female
Old Hos : 2021/2023
Patient Age : 62 Y

Family history	-VE	Phone	01120934150	BMI	30	REASON OF MDT	
marital status		NRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup : FREE

BX: IDC GII 6/23 SLIDE REVISON	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 :

T	N	M
CT2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

for LT central quadrentectomy and alnd

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ لؤي القاسم د/ آلاء جبل	RADIOLOGY	
SURGERY	د/ محمود طه	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex: Female
3- Medical number: 03145071
Old Med : 12651/2022
2-ID number: 26102080104087
Patient Age : 63 Y

Family history	-VE	Phone	01120834211	BMI	38	REASON OF MDT	POST [illegible]
marital status		BRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	2023-08-29
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :			Mets Workup : FREE		
BX: IDC	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 : 15

T	N	M
2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY
PATHOLOGY REPORT REQUESTE DATE 25/7/2023--- UP FRONT LT BCS&SLNB
FREE RESECTION MRGINS ,,AXLND
LN 3/12

MDT OUTCOME & PLAN

4 cycles DC(taxotere endoxan),, PORT,, ADJUVANT AI for 5-7 years,, baseline DEXA scan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ [illegible]	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Paychiatric		Nutrition	

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALN biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 13x8.5x4 cm , covering skin ellipse measured 13 x 4 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3 x2.5x2 cm .
- Distance from margins: 1 cm away from Superficial margin ,
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm enclosing 12ALNs up to 1.5x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: present
- Lymph node involvement: Positive SLNs (3/12)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & left SLN biopsy:
Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS
- Positive LNs (3/12)
- Free margins
- Stage : pT2 , pN1

Dr. Rana Fathy Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Room No. (4) - First Floor-Building No. 9871- 90th Corniche - Nile El Qadema- Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :
Dr.Heba Hasan

عمارة رقم (9) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - الشارع الأول - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 287- 26th Corniche - Misr El Qadeem - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 03/08/2024
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size , smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: Average size , displaying homogenous echopattern.

Right Kidney: -

- Is of normal size measures 9.9x3.8 cm showing increased echogenicity and loss of differentiation between cortex and medulla ,cortical thickness varies from 3mm opposite upper lobe and 12mm opposite lower lobe , no stone or backpressure changes , few small simple cysts.

Left Kidney: -

- Is of normal size measures 10x5 cm , altered echogenicity , no stone or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: -: average sized uterus. With calcified uterine fibroid at anterior wall

- No ascites or abnormal fluid collection.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

Opinion:

- Right renal old pyelonephritic changes as described
- Left kidney showing mild increased echogenicity for lab correlation.
- Few small simple cysts.

Best Regards,

Dr. Shahd M. Fouad, MSc, FRCR.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13000891
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 06/06/2023
Path No.	: SR-687/23	Verification Date	: 18/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion
Nature of specimen:
Slide revision
Gross examination
l slides +1 block (c-B1259)
ections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, R,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

icroscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma .
rade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
CIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
gioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
T :
Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 6/8)
2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
: 15 % nuclear reaction in tumor cells
logy slides :
lar smears showing groups and clusters of atypical ductal cells with increased nuclear lasmic ratio with inflammatoy background.

osis:
ast lesion, slide revision of tru cut and cytology slides:
duct carcinoma, Grade II .
ve (8/8)

erified by :
sraa magdy

Patient Name	الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	13000891
Patient No.	26102080104087	Request Date	06/06/2023
Path No.	SR-687/23	Verification Date	18/06/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	62 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

PR : Positive (6/8)
HER2: Negative (score0)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Israa Elgendy
Dr.Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Building No. 80 - Cairo - Egypt - 1987 - Nile Corniche - Nasr El Qobbah - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 62 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 38700/2051/2023

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- *. The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

Average size for, homogenous.

- **Kidneys: -**
- *Both are average in size, shape*
- *The right kidney shows increase echogenicity, upper zone cyst 17mm*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

***Para-aortic and pancreatic area**: show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

***Uterus and adenexeal** ; no abnormalities could be detected*

Opinion:

Right echogenic kidney with simple cyst for laboratory correlation

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 2:16 2023/06/05

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
قسم الايكو

Echo report

MR:

Name:

Date: 2023

EF	60	55-75%	PWT	1,1	
LVEDD	4,55	3.5-5.8cm	AO.R	2,27	2-3.7cm
LVESD	2,95	2-4cm	LA	3,21	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT		0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Concentric LVH

LV wall thickness normal

LV diastolic function DD G1

SWMA No RWMA.

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve mild MR

Aortic valve Sclerotic & mild AR

Tricuspid valve normal

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion No masses, no effusion

D/ Msc cardiology

MRS HANAA ABD EL RAHMAN
Date : 27/ 5 / 2023

Dear Colleague Prof.Dr. BAHAA EL WAKEEL

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY :

- The left breast show an irregular Partially ill defined dense mass in the retroareolar area
- No micro nor microcalcification seen
- No pathological lymph nodes seen

By complementary U/S

- The left breast show an irregular solid mass measuring 40 x 26 mm in the periareolar area at 7 o'clock with picture of malignant breast mass BIRAD V
- Normal size, shape, skin, subcutaneous tissue, nipples and areola
- No pathological lymph node seen , but multiple reactionary lymph nodes

OPINION :

Picture of left side breast malignant mass

MUCH OBLIGED, YOURS
DR.EID RAMADAN

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 2023/2051	38700 DLP: 677.1 (mGy.cm)

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

***** Newly discovered left breast mass:***

Findings:

- The left breast shows ill-defined speculating mass noted in the UOQ measuring about 48 x 39 mm. Clear both lung fields
- Other than thick atelectatic bands noted in the lingular and middle lobes, no sizable pulmonary nodule, masses or cavitations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***No CT evidence of pneumonia***

DR. MOHAMMED MAHJOUB

Dr. Amr Farouk, M.D.

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 25/10/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

- **Breast density:** Predominant fatty tissue ... ***Matching ACR A.***
- **Focal asymmetry is seen in the left lower outer quadrant with few lesions of fat density with dystrophic calcifications within .**
- **No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the both breasts.**
- Normal skin and nipple in the right **breast.**

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture.
- **Clear left operative bed, with few cystic lesions are seen close to 5-6 o'clock position ,the largest measures (9 x 7 mm).**
- **No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.**
- **No detected significant axillary lymph nodes.**

CONCLUSION:

- ***Post conservative surgery changes of the left breast with traumatic fat necrosis (BIRADS 2 Category).***
- ***Normal study of the right breast (BIRADS 1 Category).***

MUCH OBLIGED

DR.MONA ZAKY, MD.

prof-Breast imaging-Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

25/10/2025 11:21 AM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: هنا عبد الكريم [illegible]
رقم الملف: .....

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية: .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		اراميدكس 1x1x90	
		كالسيوم 1x1x90	
		وايت الفا 1x1x90	
		نيوروميتيك 1x1x90	
		كتروليت 1x1x30	
		ارامكس 1x1x90	
		كالسيوم	
		وايت الفا	
		نيوروميتيك	
		S.M.R	
		CXR R	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Anes workup	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ..... رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

أمانة المراكز الطبية المتخصصة

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
7/11/2023	7·8	Kidney functions rising ... creat 1.8 ..., urea 43.8 ..., UA ...	
		Postpone cycle 1 weeks & proper hydration and supportive tt	
		Zyloric 300 ...	
		CBC pending	
		4Th	
		- أبرازول	
		- أمبنيوميا	
		- دلتاميس لاصمبوميا	
		عمر عناد اغفاع	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Consult A.S

Page 1 of 1

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
4/5/21		Post Chemo SC extravasation burn Plean for 1- Mebo Cre 2- Augmentin 1g tab 3- Declofen tab 75	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		C3TC	

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: صباح عبد الرحمن
رقم الملف: 20B1123

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		(CHTC) wt 96	
		Ht 195 S.A 1.9	
		جرعة تنزيل + نصف الجرعة في اليوم الثاني والثالث	
	75mg/m²	تاكسوتير	
	600mg/m²	سيكلوفوسفاميد	
		كيز لوله	
		سيزوبنيا	
		ديفلوكسام	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	

غداً بعد الفحص الدقيق

will be taken on 26/9 C.Cx.19150

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

أمانة المراكز الطبية المتخصصة

SMC-DSH-F-PHY-O-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ...

رقم الملف: ...

W 96
L 1675
BSA 1.9

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		female pt. 62 y pt. for adjuvent eth taxotere / endoxan x 4 cycles Labs adapted exp 8 Creat 1.7 taxotere 75 mg/m² 140mg Endoxan 600mg/m² 1140 C1	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Page 1 of 1

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص:..... نوع التغذية :.....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		.....	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ..... رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		مزود الصابر بسعر عالي	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

Research Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج البحثي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex:
2-ID number: 26102080104067

3- Medical number: 83145471
Female
Old Hos : 2021/2023
Patient Age : 62 Y

Family history	-VE	Phone	01120934150	BMI	30	REASON OF MDT	
marital status		NRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup : FREE

BX: IDC GII 6/23 SLIDE REVISON	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 :

T	N	M
CT2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

for LT central quadrentectomy and alnd

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ لؤي القاسم د/ آلاء جبل	RADIOLOGY	
SURGERY	د/ محمود طه	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس Sex: Female
3- Medical number: 03145071
Old Med : 12651/2022
2-ID number: 26102080104087
Patient Age : 63 Y

Family history	-VE	Phone	01120834211	BMI	38	REASON OF MDT	POST [illegible]
marital status		BRS Score	1	GROUP	C	Date of MDT	2023-08-29
Co morbidity	HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :			Mets Workup : FREE		
BX: IDC	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : 0	SISH :	KI67 : 15

T	N	M
2	1	0

Sonomammography
LT BREAST MASS 4X2.6 CM AT 10 O'CLOCK

PATIENT HISTORY
PATHOLOGY REPORT REQUESTE DATE 25/7/2023--- UP FRONT LT BCS&SLNB
FREE RESECTION MRGINS ,,AXLND
LN 3/12

MDT OUTCOME & PLAN

4 cycles DC(taxotere endoxan),, PORT,, ADJUVANT AI for 5-7 years,, baseline DEXA scan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ [illegible]	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Paychiatric		Nutrition	

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALN biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 13x8.5x4 cm , covering skin ellipse measured 13 x 4 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3 x2.5x2 cm .
- Distance from margins: 1 cm away from Superficial margin ,
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm enclosing 12ALNs up to 1.5x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: present
- Lymph node involvement: Positive SLNs (3/12)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & left SLN biopsy:
Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS
- Positive LNs (3/12)
- Free margins
- Stage : pT2 , pN1

Dr. Rana Fathy Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Room No. (4) - First Floor-Building No. 9871- 90th Corniche - Nile El Qadema- Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13002848
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 25/07/2023
Path No.	: 2347/23	Verification Date	: 12/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :
Dr.Heba Hasan

عمارة رقم (9) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - الشارع الأول - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 287- 26th Corniche - Misr El Qadeem - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 03/08/2024
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size , smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: Average size , displaying homogenous echopattern.

Right Kidney: -

- Is of normal size measures 9.9x3.8 cm showing increased echogenicity and loss of differentiation between cortex and medulla ,cortical thickness varies from 3mm opposite upper lobe and 12mm opposite lower lobe , no stone or backpressure changes , few small simple cysts.

Left Kidney: -

- Is of normal size measures 10x5 cm , altered echogenicity , no stone or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: -: average sized uterus. With calcified uterine fibroid at anterior wall

- No ascites or abnormal fluid collection.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

Opinion:

- Right renal old pyelonephritic changes as described
- Left kidney showing mild increased echogenicity for lab correlation.
- Few small simple cysts.

Best Regards,

Dr. Shahd M. Fouad, MSc, FRCR.

Patient Name	: الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	: 13000891
Patient No.	: 26102080104087	Request Date	: 06/06/2023
Path No.	: SR-687/23	Verification Date	: 18/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion
Nature of specimen:
Slide revision
Gross examination
l slides +1 block (c-B1259)
ections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, R,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

icroscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma .
rade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
CIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
gioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
T :
Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 6/8)
2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
: 15 % nuclear reaction in tumor cells
logy slides :
lar smears showing groups and clusters of atypical ductal cells with increased nuclear lasmic ratio with inflammatoy background.

osis:
ast lesion, slide revision of tru cut and cytology slides:
duct carcinoma, Grade II .
ve (8/8)

erified by :
sraa magdy

Patient Name	الأستاذه / هناء عبدالرحمن عبدالمقصود يونس	Request No.	13000891
Patient No.	26102080104087	Request Date	06/06/2023
Path No.	SR-687/23	Verification Date	18/06/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	62 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

PR : Positive (6/8)
HER2: Negative (score0)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Israa Elgendy
Dr.Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Building No. 80 - Cairo - Egypt - 1987 - Nile Corniche - Nasr El Qobbah - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 62 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 38700/2051/2023

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- *. The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

Average size for, homogenous.

- **Kidneys: -**
- *Both are average in size, shape*
- *The right kidney shows increase echogenicity, upper zone cyst 17mm*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

***Para-aortic and pancreatic area**: show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

***Uterus and adenexeal** ; no abnormalities could be detected*

Opinion:

Right echogenic kidney with simple cyst for laboratory correlation

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 2:16 2023/06/05

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
قسم الايكو

Echo report

MR:

Name:

Date: 2023

EF	60	55-75%	PWT	1,1	
LVEDD	4,55	3.5-5.8cm	AO.R	2,27	2-3.7cm
LVESD	2,95	2-4cm	LA	3,21	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT		0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Concentric LVH

LV wall thickness normal

LV diastolic function DD G1

SWMA No RWMA.

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve mild MR

Aortic valve Sclerotic & mild AR

Tricuspid valve normal

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion No masses, no effusion

D/ Msc cardiology

MRS HANAA ABD EL RAHMAN
Date : 27/ 5 / 2023

Dear Colleague Prof.Dr. BAHAA EL WAKEEL

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY :

- The left breast show an irregular Partially ill defined dense mass in the retroareolar area
- No micro nor microcalcification seen
- No pathological lymph nodes seen

By complementary U/S

- The left breast show an irregular solid mass measuring 40 x 26 mm in the periareolar area at 7 o'clock with picture of malignant breast mass BIRAD V
- Normal size, shape, skin, subcutaneous tissue, nipples and areola
- No pathological lymph node seen , but multiple reactionary lymph nodes

OPINION :

Picture of left side breast malignant mass

MUCH OBLIGED, YOURS
DR.EID RAMADAN

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 05/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 2023/2051	38700 DLP: 677.1 (mGy.cm)

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

***** Newly discovered left breast mass:***

Findings:

- The left breast shows ill-defined speculating mass noted in the UOQ measuring about 48 x 39 mm. Clear both lung fields
- Other than thick atelectatic bands noted in the lingular and middle lobes, no sizable pulmonary nodule, masses or cavitations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***No CT evidence of pneumonia***

DR. MOHAMMED MAHJOUB

Dr. Amr Farouk, M.D.

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 25/10/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

- **Breast density:** Predominant fatty tissue ... ***Matching ACR A.***
- **Focal asymmetry is seen in the left lower outer quadrant with few lesions of fat density with dystrophic calcifications within .**
- **No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the both breasts.**
- Normal skin and nipple in the right **breast.**

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture.
- **Clear left operative bed, with few cystic lesions are seen close to 5-6 o'clock position ,the largest measures (9 x 7 mm).**
- **No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.**
- **No detected significant axillary lymph nodes.**

CONCLUSION:

- ***Post conservative surgery changes of the left breast with traumatic fat necrosis (BIRADS 2 Category).***
- ***Normal study of the right breast (BIRADS 1 Category).***

MUCH OBLIGED

DR.MONA ZAKY, MD.

prof-Breast imaging-Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

25/10/2025 11:21 AM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Rahman Abd Al Maksoud Yonis	Date : 19/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2051/2023	Pat. ID: 38700

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: هنا عبد الكريم [illegible]
رقم الملف: .....

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية: .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		اراميدكس 1x1x90	
		كالسيوم 1x1x90	
		وايت الفا 1x1x90	
		نيوروميتيك 1x1x90	
		كتروليت 1x1x30	
		ارامكس 1x1x90	
		كالسيوم	
		وايت الفا	
		نيوروميتيك	
		S.M.R	
		CXR R	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Anes workup	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ..... رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب

أمانة المراكز الطبية المتخصصة

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
7/11/2023	7·8	Kidney functions rising ... creat 1.8 ..., urea 43.8 ..., UA ...	
		Postpone cycle 1 weeks & proper hydration and supportive tt	
		Zyloric 300 ...	
		CBC pending	
		4Th	
		- أبرازول	
		- أمبنيوميا	
		- دلتاميس لاصمبوميا	
		عمر عناد اغفاع	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Consult A.S

Page 1 of 1

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
4/5/21		Post Chemo SC extravasation burn Plean for 1- Mebo Cre 2- Augmentin 1g tab 3- Declofen tab 75	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		C3TC	

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: صباح عبد الرحمن
رقم الملف: 20B1123

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		(CHTC) wt 96	
		Ht 195 S.A 1.9	
		جرعة تنزيل + نصف الجرعة في اليوم الثاني والثالث	
	75mg/m²	تاكسوتير	
	600mg/m²	سيكلوفوسفاميد	
		كيز لوله	
		سيزوبنيا	
		ديفلوكسام	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	

غداً بعد الفحص الدقيق

will be taken on 26/9 C.Cx.19150

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

أمانة المراكز الطبية المتخصصة

SMC-DSH-F-PHY-O-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ...

رقم الملف: ...

W 96
L 1675
BSA 1.9

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		female pt. 62 y pt. for adjuvent eth taxotere / endoxan x 4 cycles Labs adapted exp 8 Creat 1.7 taxotere 75 mg/m² 140mg Endoxan 600mg/m² 1140 C1	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Page 1 of 1

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص:..... نوع التغذية :.....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		.....	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

إسم المريض ثلاثي: ..... رقم الملف: .....

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: ..... نوع التغذية : .....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		مزود الصابر بسعر عالي	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022